



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : سماح حمدي زكي رضوان
المحافظة : القليوبية
الحى / المدينة : شبرا الخيمة اول العنوان : 0
رقم البطاقة : 28303122100349 رقم التليفون : 01225287994 تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 12-03-1983 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سماح حمدي زكي رضوان National ID: 28303122100349	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

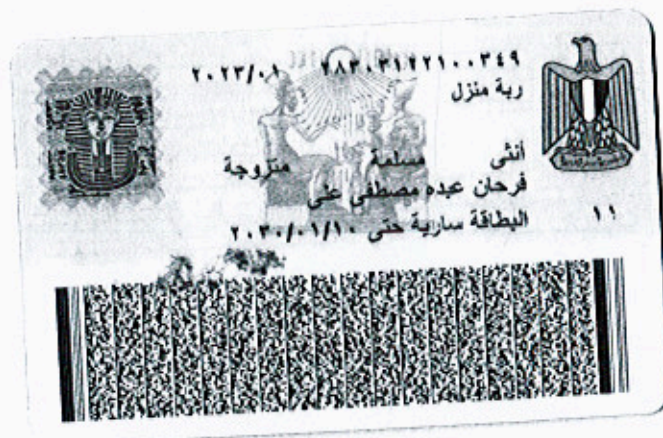
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name	: الأستاذ / سماح حمدي زكي رضوان	Request No.	: 13006078
Patient No.	: 28303122100349	Request Date	: 23/04/2026
Path No.	: 1153/26	Verification Date	: 13/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post-NACT.

Nature of specimen: Left modified radical mastectomy& Extra-deep margin.

Gross Examination:

Two specimens were received as follow:

1- Left modified radical mastectomy specimen measured 22x18x5 cm, with covering skin ellipse measured 18x12 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.

* Serialling showed a rubbery focally firm grey white tumor bed site 4x3x2.5 cm, located 0.3 cm from the least inked deep margin.

* Axillary fat entangling 9 lymph nodes (after careful dissection), the largest measured 1x1x0.5 cm.

2- Extra-deep margin: Fibrofatty tissue piece measured 5x5x1 cm.

* 10 Blocks:

1:3- T.B.S. 4- TBS & Deep margin., 5- N&A., 6:9- ALNs., 10- Extra- deep margin.

- Gross was done by; Dr. Heba Hassan.

Microscopic examination:

* Histological type: Residual viable invasive duct carcinoma with medullary like features.

* Grade 3 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 3, mitosis 2).

* Tumor cellularity: 15%.

* Actual tumor size: 4x3 cm.

* Ductal carcinoma in situ: Absent.

* Angioinvasion: Present.

* Perineural invasion: Absent.

* Necrosis: Extensive.

* Nipple and areola: Free.

* Deep margin: Free adherent deep margin.

* Extra-deep margin: Free.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed



Patient Name	: الأستاذ / سماح حمدي زكي رضوان	Request No.	: 13006078
Patient No.	: 28303122100349	Request Date	: 23/04/2026
Path No.	: 1153/26	Verification Date	: 13/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوسفاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- * Axillary lymph nodes: Positive viable metastatic deposits in one out of nine (1/9) LNs (The metastatic focus measuring 0.4 cm, with extra-nodal extension).
- * Histologic response to therapy: Pathologic partial response to therapy.

Diagnosis:

- Left breast cancer (Post-NACT), Left modified radical mastectomy & Extra-deep margin:
- Residual viable invasive duct carcinoma with medullary like features, Grade 3 (Cellularity 15%) (Actual tumor size 4x3 cm).
 - Ductal carcinoma in situ: Absent.
 - Nipple & areola: Free.
 - Deep margin: Free.
 - Extra-deep margin: Free.
 - Axillary lymph nodes: Positive viable metastatic deposit in one out of nine axillary lymph nodes (The metastatic focus measuring 0.4 cm, with extra-nodal extension).
 - Stage: ypT2, ypN1a.
 - RCB: 3.118, RCB class-II.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed



03/29/2026

MDT FORM

Name:	Samah Hamde Zaki .	MRN:	1187
Age:	43 Y	ID:	28303122100349
Menopausal Sta	PREMENOPAUSAL	Phone:	
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	POST NACT

Clinical Data:

R

L

BX: IDC G3
ER: 0/8 PR: 2/8 HER2: 0 KI67: 90%

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

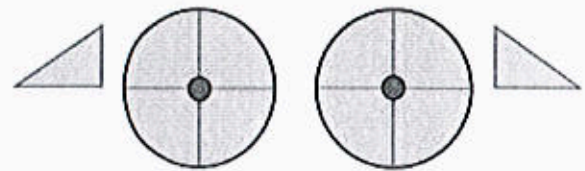
CLIPS INSERTED AND RECIEVED AC *4+TAXWAL *12WEEKS ..LAST CYCLE
5/3/2026 ..SM REQ

Recommendations:

FORFOR LT WLE +SLNB AS PLANNED DR NBRAWY

MDT Outcome & Plan

FOR LT WLE +SLNB



T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Dr Hanan Ezzat	Dr Ahmed Naguib				

MDT FORM 19/8/2025 G

Name	سماح محمد زكي	MRN	1551889173
Age	41 سنة	ID	1550887998
Menopausal status	pre	Phone	00/1989
NRS SCORE		Marital status	Married
BMI		Family history	None
CO morbidity		REASON OF MDT	New
CA3.31CC1.0389			

Clinical Data

BX: IDC GIII

ER: 018 PR: 218 HER 2: 0 Ki67: 90%

Sonomammography: ACR C 29/7/2025

4.8 X 3.6 cm, abutting m.s.
multiple level 1 LRS

Mets Workup:

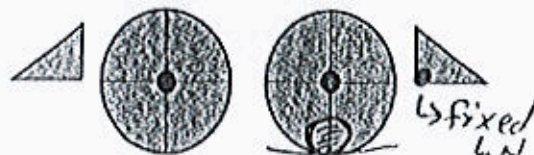
CT CAP

all ct sup. & b. & a.

R

MDT

L



fixed L.N.
inseparable from skin

c local TNM
T₃N₁M₀

Recommendations:

for clipping from NACT then BCS
عمل

MDT OUTCOME & PLAN

* CESM + Clipping

* NACT AC X 4

1 Tbx 12 weeks

* surgical decision will decided after NACT

CESM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
M. Kelma	Dr Haseb 19/8/2025				

Patient Name	: الأمانة / سمح حمدي زكي رضوان	Request No.	: 13003639
Patient No.	: 28303122100349	Request Date	: 30/06/2025
Path No.	: 2164/25	Verification Date	: 07/07/2025
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data

Left breast mass

Nature of specimen

Tru cut biopsy, collected on 29/6/2025

Gross examination

Multiple grayish white tissue cores up to 0.4 cm, totally submitted.

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+3+2) Grade 3
- * DCIS: Absent
- * Angioinvasion: Absent
- * Perineural invasion: Absent
- * Additional pathological findings : moderate necrosis
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
- * PR: Weak nuclear reaction in <1 % tumor cells (Allred score 2/8)
- * HER2: No membrane reaction in of tumor cells (score 0)
- * Ki 67: 90 %

Diagnosis

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 08/07/2025 10:07:29

Page 1 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / سماح حمدي زكي رضوان
Patient No. : 28303122100349
Path No. : 2164/25
Sex : Female
Age : 42 Y
Referreing Doc :

Request No. : 13003639
Request Date : 30/06/2025
Verification Date : 07/07/2025
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Left breast mass, Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade 3
IPT:

- * ER: Negative (score 0/8).
- * PR: Negative (score 2/8).
- * HER2: Negative (score 0).
- * Ki67: 90 %

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr. Heba Hassan Adly

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Printing Date : 08/07/2025 10:07:29

Page 2 of 2

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Samah Hamdy Zaky Radwan	Date : 29/07/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 28303122100349	Pat. ID: 110754
7690	

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

Left breast palpable lump

TECHNIQUE:

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

REPORT:

- Dense fibro glandular density, (ACR C).
- The left LIQ is the seat of a partially visualized irregular mass.
- Complementary U/S revealed an underlying irregular heterogenous mass, abutting the underlying pectoral muscle, located at 8 o'clock, consistent with the palpable lump, measuring 4.8x3.6cm, with subtle vascularity detected within on color Doppler application.
- Multiple left level I pathological axillary lymph nodes are seen with loss of their fatty hila, measuring up to 29x15mm.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex both breasts.
- Right nonspecific axillary nodes.

OPINION:

- Left breast LIQ malignant mass. (BIRADS 5) for histopathological correlation.
- Normal right breast, (BIRADS 1).

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar

Patient Name: Samah Hamdy Zaky Radwan	Date : 30/07/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 1949/2025	Pat. ID: 110754

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST , ABDOMEN AND PELVIS

Reported case of breast cancer

- Left breast mass measuring 3.6 x 3.5 cm .
- Enlarged left axillary L. Ns with the largest measures 2.3 x1.6 cm.
- Bilateral upper lobes multiple calcified nodules the largest at left upper lobe measures 7mm, likely post granulomatous disease.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average size cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal appearance of the chest wall.
- II Abdomen & pelvis:
- The liver is average size in size with homogenous CT texture. Small hypodense focal lesion measures 7 x5 mm at segment V likely cystic .
- Average size gall bladder with thick wall and multiple gall stones.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both suprarenals.
- Normal appearance of the other visualized pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- IUCD in place.

II. Scanned skeleton:

- Small sclerotic lesion of left symphysis pubis likely bone island , otherwise No worrisome lytic or sclerotic bony lesions.

Opinion:

- Left breast mass with axillary lymphadenopathy.
- No pulmonary , or hepatic metastatic deposits

Patient Name: Samah Hamdy Zaky Radwan	Date : 30/07/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 1949/2025	Pat. ID: 110754

DR/Reham Khedr,,MD

30/7/2025

Not Approved

112V

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
مستشفى احمد ماهر التعليمي

The General Organization for Teaching Hospitals
and Institutes

Ahmad Maher Teaching Hospital



To whom it may concern

Mrs. / Mr. Christine Elhassan, 43 years old

Female male patient presented with diagnosis

left breast cancer

She/ He was referred to us for (radical adjuvant / Neoadjuvant /
palliative) Radiotherapy

She/ He has received (3D/IMRT) radiotherapy to

left chest + axilla

At Dose : 46Gy/15 fx

Additional (Boost) : yes/ no. at dose 10Gy/5 fx

(sequential / concomitant)

Started: 6.12.2020

Ended: 2.1.2021 With good tolerance.

Head of department
Dr. Othman William

Dr. Othman William